Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
4ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50, 9° andar, sala 907 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent4vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5257253-72.2024.8.21.0001/RS

AUTOR: LEONARDO DE MOURA FERNANDES

RÉU: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

SENTENÇA

LEONARDO DE MOURA FERNANDES ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes devidamente qualificadas. Narrou ser beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão firmado com a Ré. Referiu que, após tomografia realizada em 22/09/2023, foi diagnosticado com neoplasia maligna primária do córtex adrenal metastático (CID C74), doença rara com menos de 200 casos descritos na literatura médica. Mencionou ter sido submetido a cirurgia emergencial em 11/10/2023, mas que, em setembro de 2024, exames apontaram progressão da doença, sendo indicado o uso dos medicamentos **Xtandi (Enzalutamida)** e **Lisodren (Mitotano)**. Destacou que a Ré, apesar de ter custeado voluntariamente o procedimento cirúrgico inicial, negou a cobertura do tratamento atual com base na ausência de Diretriz de Utilização da ANS. Ressaltou que o medicamento possui registro na ANVISA desde 2019, consta no Rol da ANS e tem indicação expressa em bula para o tratamento do tipo de câncer que o acomete. Acrescentou ainda que o FDA aprovou o uso do Mitotano desde 1970 para o mesmo tipo de carcinoma, e que notas técnicas do NATJUS reconhecem o benefício clínico da terapia. Por fim, informou que teve de custear o primeiro ciclo do tratamento com recursos próprios diante da negativa da operadora. Requereu em sede de tutela antecipada o fornecimento do medicamento e o reembolso dos valores já despendidos. Juntou documentos. Pugnou pela gratuidade judiciária.

Deferida a gratuidade judiciária, foi solicitado nota técnica ao NATJus/TJRS. (evento 4, DESPADEC1).

Foi acostado aos autos documento encaminhado pelo NATJus/TJRS favorável ao deferimento da tutela provisória (evento 7, ANEXO1).

Deferido o pedido antecipatório (evento 9, DESPADEC1).

Citada, a ré contestou (evento 24, CONT1). Alegou que o autor é beneficiário de seguro saúde coletivo empresarial desde abril de 2023, e que o contrato firmado estabelece direitos e obrigações com base na cobertura contratada. Referiu que o fornecimento do medicamento Lisodren (Mitotano), solicitado pelo autor, não possui cobertura contratual, uma vez que não consta no rol da ANS para a patologia apresentada. Mencionou que a negativa de cobertura foi baseada na ausência de previsão do medicamento no rol da ANS e nas diretrizes de utilização vigentes, argumentando que a cobertura obrigatória está limitada aos tratamentos expressamente previstos. Sustentou que a operadora atua de forma suplementar ao SUS, e que obriga-la a custear medicamentos não previstos compromete a sustentabilidade financeira da operadora. Defendeu a improcedência do pedido da parte autora e a reforma da decisão liminar.

Intimadas as partes a dizerem sobre o interesse na produção de provas, nada requereram.

A parte autora insurgiu-se à tese defensiva da demandada e requereu a aplicação de litigância de má-fé (evento 35, PET1). Juntou comprovantes do medicamento adquirido (evento 36, PET1).

A parte demandada manifestou-se (evento 54, PET1).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, não havendo necessidade de outras provas, conforme dita o artigo 355, I, do CPC.

Passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a parte autora, portadora de neoplasia maligna primária do córtex adrenal metastático (CID C74), pretende o fornecimento de medicamento/custeio de tratamento Lisodren (MITOTANO) em vista da negativa de fornecimento pela ré.

De início, observo que a relação entretida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, o que já se encontra sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

"*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)."

Tratando-se de demanda envolvendo o dever do plano de saúde em custear tratamento médico, é fundamental lembrar que está em jogo um direito fundamental, o direito à saúde, classificado como direito de segunda geração e expressamente assegurado pela Constituição Federal, conforme disposto nos artigos 6º e 196, cujos termos destacam a relevância desse direito como garantia essencial.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No tocante ao direito à saúde suplementar, a legislação pátria compreende determinados normativos, isto é, a Lei nº 9.656/1998 e os atos regulamentares infralegais da ANS e do Conselho de Saúde Suplementar, os quais conferem densidade normativa ao direito constitucional à saúde.

No caso sub judice, a doença é coberta pelo contrato, e o medicamento foi prescrito ao autor pelo médico assistente, sob alegação de progressão da doença e morte precoce, bem como "*ser o único medicamento aprovado pela FDA desde 1950 não havendo outra alternativa terapêutica no rol da ANS que possa ser utilizada até os dias atuais".*

A demandada negou a cobertura postulada, argumentando que, em que pese o medicamento constar na lista dos medicamentos cobertos pela referida Diretriz de Utilização, somente haveria indicação caso a doença fosse inoperável, conforme consta no Anexo II da Resolução 465/2021:

Midostaurina	aguda	pacientes com mutação de FLT3.
Mitotano	Córtex suprarenal	Carcinoma inoperável.
	LMC - Leucemia Mielocítica	Adultos com leucemia mieloide crônica cromossomo

No entanto, no caso do autor, a necessidade do tratamento vem evidenciada pelo documento do **evento 1, LAUDO8**, e a **<u>evolução do quadro do autor, mesmo após a operação</u>** ,que assim dispõem:

> Paciente realizou em 2023 cirurgia de tumor primário do córtex adrenal. De acordo com o estadimanento inicial e do subtipo mais raro do carcinoma adrenal (menos de 200 casos descritos na literatura), oncocitico, foi optado por nao realizar tratamento adjuvante com quimioterapia sistemica ou oral. Entretanto, no seguimento clinico do paciente observou-se exames horonais e de imagem compatíveis com recorrencia da doença, cuja sobrevida livre de recorrencia foi abaixo de um ano, denotanto a agressividade do coportamento biológico do tumor. O paciente necessita urgentemente do quimioterapico oral (MITOTANO) para tratamento do **câncer adrenal metastático**, sob pena de progressão da doença e morte precoce. O mitotano **é o unico medicamento aprovado pelo FDA** desde 1950, **nao havendo outra alternativa terapêutica no rol da ANS** que possa ser utilizada até os dias atuais.
>
> Os exames de imagem e laboratoriais que identificam recorrencia da doença seguem em anexo.
>
> O carcinoma adrenocortical (incidÊncia de 1 a 2 casos por milhao por ano) é uma das neoplasias solidas mais agressivas na prática clínica da oncologia. Desde 1989 em conjunto com uma equipe que dirijo de oncologistas, urologistas, radiointervencionistas, tratamos os pacientes adultos e pediátricos. Realizo pesquisa na área assim como sou membro atuante das organizaçoes internacionais que estudam e tratam pacientes com carcinoma adrenocortical (ENSAT, ENSATkids).

Contudo, a negativa imposta a partir do não preenchimento dos requisitos da DUT(diretriz de utilização) não pode ser fator de exclusão de cobertura do procedimento. Nesse sentido, vejamos julgamentos de casos análagos pelo E. Tribunal de Justiça do nosso estado:

> ***Ementa:*** *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.* ***MEDICAMENTO****. ROMOSOZUMABE. NEGATIVA DE* ***FORNECIMENTO****. N****ÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. DEVER DE COBERTURA. REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS****. OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS AO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 608, STJ), PORTANTO, AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEVEM SER INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. NÃO CABE AOS PLANOS DE SAÚDE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA, DETENTOR DO CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA MELHOR CONDUZIR O TRATAMENTO DE SEUS PACIENTES, SOBRETUDO PELA PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE EM CONFLITO COM DEMAIS INTERESSES. CASO EM QUE O BENEFICIÁRIO, PORTADOR DE NEUROMIELITE ÓPTICA E OSTEOPOROSE INDUZIDA POR CORTICOTERAPIA, NECESSITA FAZER USO DO FÁRMACO ROMOSOZUMABE, QUE, ALÉM DE SER PROCEDIMENTO INCORPORADO ÀS COBERTURAS MÍNIMAS, NOS TERMOS DA LEI N. 9.656/1998, ARTIGO 12, INCISOS I, ALÍNEA 'B', VISTO SER REALIZADO EM AMBIENTE AMBULATORIAL, SE TRATA DE PROCEDIMENTO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA NO TIPO DE PLANO DO BENEFICIÁRIO. PORTANTO, O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA DUT DO* ***MEDICAMENTO*** *NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA, SENDO CASO DE SER DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA OBRIGAR A RÉ A FORNECER O* ***MEDICAMENTO*** *PLEITEADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52783317720248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 26-02-2025).(grifos nossos).*
>
> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO OCRELIZUMABE. APLICAÇÃO HOSPITALAR. ROL DA ANS. RECUSA DE* ***FORNECIMENTO*** *INDEVIDA. PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEVEM ESTAR PRESENTES OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 300 CPC, QUAIS SEJAM, A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NO CASO, A PARTE AUTORA FOI DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA (CID 10 G35), NECESSITANDO DE TRATAMENTO COM APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO OCRELIZUMABE. NÃO SE TRATA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, DIANTE DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTRAVENOSA.* ***OUTROSSIM, É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA QUE A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA "DUT 65" (DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR) NÃO AFASTA O DEVER DO PLANO DE SAÚDE DE FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE, SOBRETUDO QUANDO PREVISTO NO ROL***

DA ANS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 50287663120248217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-04-2024) (grifos nossos).

Outrossim, colaciono trecho extraído de nota técnica elaborada pelo NatJus para o presente processo:

Evidências e resultados esperados

Tecnologia: MITOTANO

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: Mitotano é um congênero de inseticida diclorodofeniltricloroetano (DDT), que tem uma ação adrenocorticolítica sobre carcinoma adrenocortical, seja em combinação com outro quimioterápico, seja como monoterapia, sobre o carcinoma irressecável ou recorrente (1). Apesar de ter uma ação considerada de curta duração, muitas vezes. (1)
A eficácia está demonstrada em alguns estudos (1), sendo recomendada como droga para tratamento de recorrência ou tumor que não pode ser ressecado. (1)

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Melhorar resposta ao tratamento oncológico (com ou sem quimioterapia associada), controle da recidiva, controle dos sintomas.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada

Conclusão

Tecnologia: MITOTANO

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Considerando que, conforme consta nos documentos médicos apensos, o autor é portador de carcinoma adrenocortical (CAC) subtipo oncocítico recidivado, tratando-se de tumor bastante raro e agressivo;
Considerando que o demandante foi submetido a cirurgia para ressecção do tumor (tratamento de primeira linha realizado pelo SUS) logo após o diagnóstico, seguida por recidiva precoce com termoablação de doença retroperitoneal (procedimento este custeado por meios próprios):
Considerando que o tratamento demandado é preconizado em guidelines internacionais elaborados por sociedades de especialistas e suportado por evidências científicas, que apontam para o benefício do seu uso no aumento de sobrevida global e de diminuição de recidivas;
Considerando que o mitotano é o único medicamento de uso aprovado para tratamento de carcinoma adrenocortical, sendo aprovado pela ANVISA para esta indicação;
Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda.

Assim, não guarda legitimidade a negativa da cobertura do tratamento em questão ao autor, tão somente pelo não preenchimento da DUT, uma vez que comprovada a necessidade do procedimento e esse estar incluído no rol de procedimento de cobertura da ANS. Por isso, julgar procedente tal pedido, é medida que se impõe.

Acresço, por pertinente, que diante da obrigatoriedade do fornecimento da medicação mostra-se ilegítima a recusa da operada em outubro de 2024 (evento 1, OUT15), o que obrigou o autor a adquirir com recursos próprios os fármacos, conforme notas acostadas no ev. 36, razão pela qual deverá a ré ressarcir o autor do montante despendido no valor de R$36.784,33.

Por fim, não vislumbro presente nenhuma das condutas descritas no art. 80, do CPC, a ensejar a aplicação das penas por litigância de má-fé.

Isso posto, confirmo a tutela de urgência deferida, e **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **LEONARDO DE MOURA FERNANDES**em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA**, a teor do artigo 487, I, do CPC, para determin à ré que **forneça ou custeie o medicamento Lisodren (Mitotano)**, conforme receituário e laudo anexos evento 1, LAUDO8, e, condenar a requerida ao reembolso dos valores pagos pelo autor para a aquisição do fármaco, no valor de R$36.784,33, atualizado pela taxa SELIC, abatido o IPCA, a contar da citação.

Devido a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e fixo honorários advocatícios em R$ 3.500,00 ao patrono da parte autora, a teor do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, consoderando o tempo de tramitação do feito, o trabalho desenvolvido e a natureza da lide que prescinde da dilação probatória ampla.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Transitada em julgado, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **SILVIA MARIA PIRES TEDESCO, Juíza de Direito**, em 15/06/2025, às 16:49:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10084633642v14** e o código CRC **f560004f**.